

INFECCÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU)



ROTINA CLÍNICA

Modelos de prescrição

CISTITE

- **Uso oral (antimicrobianos):**

Nitrofurantoína 100 mg ----- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6/6h por 5 dias.

Ou

Sulfametoxazol+trimetoprima 800/160 mg --

-- 6 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 3 dias.

Ou

Fosfomicina trometamol 3g ----- 1 sachê

Diluir o conteúdo de 01 sachê em 01 copo de água (aprox. 100 ml) e ingerir em dose única.



ROTINA CLÍNICA

CISTITE

- **Uso oral (antimicrobianos):**

Norfloxacino 400 mg ---- 6 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 3 dias.

Ou

Amoxicilina+Clavulanato 500/125 mg ---- 9 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h por 3 dias.

- **Sintomáticos:**

Dipirona 500 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas em caso de dor ou febre.



ROTINA CLÍNICA

CISTITE

- **Sintomáticos:**

Paracetamol 500 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas em caso de dor ou febre.

Cloridrato de fenazopiridina 200 mg ---- 1 caixa

Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de dor ao urinar.

***Atenção: o medicamento altera a cor da urina (urina fica alaranjada).**

Escopolamina 10 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6/6h em caso de dor abdominal.



CISTITE

- **Orientações:**

Procurar atendimento médico imediatamente caso não haja melhora e/ou piora dos sintomas em 48 horas,
E caso haja presença de sinal de alarme.

Sinais de alarme: febre alta que não melhora com uso de medicação, dor lombar intensa sem melhora com medicação e queda do estado geral.

Oriento paciente a realizar higiene íntima adequadamente, e após relações sexuais.

Oriento a não segurar urina. Quando tiver vontade de urinar, vá ao banheiro.



PIELONEFRITE

- **Não complicada (antimicrobianos):**

Ciprofloxacino 500 mg ---- 14 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 7 dias.

Ou

Amoxicilina+clavulanato 875/125 mg ---- 14 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 7 dias.

Sintomáticos e orientações similares às do paciente com cistite.

Adicional: Dose de Ceftriaxona 1g (EV ou IM) pode ser administrada ainda na UPA, PS ou UBS.



ROTINA CLÍNICA

PIELONEFRITE

- **Complicada:**

Ceftriaxona 1g F/A ---- 2 frascos

Diluir o conteúdo de 2 frascos em 100 ml de soro fisiológico 0,9% e infundir durante 1 hora uma vez ao dia.

Bromoprida 10 mg injetável ---- 1 ampola

Diluir o conteúdo de 01 ampola em 8 ml de soro fisiológico 0,9% e infundir em bolus lento de 8/8h em caso de náuseas e/ou vômitos.

Dipirona 1 g injetável ---- 1 ampola

Diluir o conteúdo de 1 ampola em 8 ml de soro fisiológico 0,9% e infundir em bolus de 6/6h em caso de dor e/ou febre.



DETALHAMENTO

- Em caso de pacientes com indicação de internação e uso recente de antimicrobianos (nos últimos 3 meses) ou falha ao tratamento oral, considerar realizar o **ESCALONAMENTO** da terapia antimicrobiana.
- O escalonamento, em geral, ocorre na seguinte ordem: Ceftriaxona -> Piperacilina+Tazobactam ou Cefepime -> Meropenem
- Vale citar que Ceftriaxona **não** possui ação contra pseudomonas.
- Sempre **descalonar** ou **escalonar** conforme o **perfil de sensibilidade** evidenciado na urocultura.



DETALHAMENTO

- **Como prescrever?**
- Piperacilina+Tazobactam 4,5g F/A: Diluir o conteúdo de 1 ampola em 100 mL de SF 0,9% e infundir em 30 a 60 minutos de 6/6h.
- Cefepime 1g F/A: Diluir o conteúdo de 1 ampola em 100 mL de SF 0,9% e infundir em 60 minutos de 12/12h*.
- Meropenem 1g F/A: Diluir o conteúdo de 1 ampola em 100 mL de SF 0,9% e infundir em 60 minutos de 8/8h.

Caso seja necessário ajuste de dose, recomendamos o **Guia Farmacêutico do Hospital Sírio Libanês** (acesso online e gratuito).



ROTINA CLÍNICA

CISTITE DE REPETIÇÃO

Lembrar sempre da definição: 3 ou mais infecções em 1 ano, ou 2 ou mais em 6 meses.

- **Medidas comportamentais:**

Ingesta hídrica adequada (em geral, 2 a 3 litros de água por dia, exceto se houve restrição hídrica).

Evitar uso de espermicida.

Orientar micção pós-coito.

Higiene adequada (limpar-se de frente para trás para evitar a contaminação do períneo com flora fecal).



CISTITE DE REPETIÇÃO

- **Profilaxia antimicrobiana:**

Contínua (uso diário do antimicrobiano por 3 a 6 meses, ou até mais) ou pós-coito (dose única pós-coito).

Sugestões para profilaxia contínua:

Nitrofurantoína 100 mg ---- Uso contínuo

Tomar 1 comprimido à noite (antes de dormir) por 03 meses.

Fosfomicina 3g ---- Uso contínuo

Diluir o conteúdo de 1 sachê em 100 mL de água e tomar a cada 7 a 10 dias.

Sugestões para profilaxia pós-coito:

Nitrofurantoína 100 mg ou

Sulfametoxazol+trimetoprima 400/80 mg:

Tomar 1 comprimido, em dose única, pós-coito.



ROTINA CLÍNICA

CISTITE DE REPETIÇÃO

- **Outras medidas farmacológicas:**

Nas mulheres com **atrofia genital**, podemos utilizar terapia com estrogênio tópico (caso não existam contraindicações). Sugestão: **Estriol** (creme vaginal 1 mg/g). Aplicar 1 mg por dia por 30 dias. Após esse intervalo, aplicar 1 mg, 2 a 3 vezes por semana, por 6 meses. É fundamental ser realizado seguimento com ginecologista.

Cranberry (reduz a adesão bacteriana ao trato urinário). Sugestão: Cápsula de 500 mg de 12/12h ou 240 mL de suco de cranberry por dia.

Lisado bacteriano (efeito imunoterápico). Sugestão: Lisado bacteriano de *Escherichia coli*. Tomar 1 cápsula pela manhã em jejum, por 3 meses.



OBSERVAÇÃO

- **Bacteriúria assintomática:**
- Diagnóstico microbiológico (em pacientes assintomáticos, a presença de > 100.000 UFC/mL em duas uroculturas consecutivas para mulheres, ou em uma amostra para homens).
- Tratar em gestantes, neutropênicos, pré-operatório de cirurgias urológicas.

